

0.1 Entstehung und Mechanismus

Nach **Extremitäten-Trauma / OP** greifen **entzündliche, nervale** und **autonome** Anteile **zusammen** und münden in eine **regionäre Fehlregulation** mit **disproportionalem Schmerz und Zeichen**.

Zuerst ausschließen: Infekt · Kompartment · Ischämie · TVT.

Unbehandelt: Chronifizierung + Funktionsverlust.

Das CRPS-Label darf **nicht** darüber hinwegtäuschen, dass sich darunter Infekt, Kompartmentsyndrom oder Gefäßnotfall verbergen kann.

Trügerische Erklärungen Maske → klinische Wahrheit

„Normaler Heilungsschmerz“	entwarnt bei klarer Disproportionalität und vegetativen Zeichen nicht
„Psychosomatik / Überempfindlichkeit“	psychische Anteile schließen organische Notfall-DDx und CRPS nicht aus
„Nur Nervenläsion / isolierte Neuropathie“	isolierte Nervenverletzung erklärt kein volles regionales vegetativ-trophisches Bild
„Entzündliches CRPS bei Fieber/Eiter“	Infektzeichen (Osteomyelitis, septische Arthritis, Wundinfekt) haben Vorrang vor dem CRPS-Label